



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN KREDENSIAL DAN
REKREDENSIAL STAF MEDIS
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 946.2/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

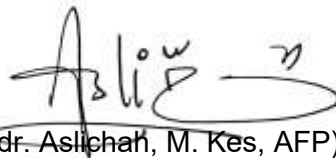
Tentang
Panduan Kredensial dan Re Kredensial Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh :
Ketua Komite Medik Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp. PD)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Asliah, M. Kes, AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

- 1. Dr. dr. Ashlichah, M. Kes, AFP

PENYUSUN

- 1. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp. PD
- 2. dr. Robby, Sp. An-Ti
- 3. dr. Denny Prasetyo, Sp. An-ti
- 4. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
- 5. dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD
- 6. dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp. OT
- 7. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis ini dapat disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan proses kredensial dan rekredensial dokter di rumah sakit.

Panduan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap Dokter yang memberikan pelayanan telah melalui proses penilaian kompetensi dan memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai dengan standar profesi, kebutuhan pelayanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permenkes No. 49 Tahun 2013 dan standar akreditasi.

Melalui panduan ini, diharapkan proses kredensial dan rekredensial dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien serta peningkatan mutu pelayanan staf medis. Panduan ini juga menjadi pedoman bagi Komite Medis, khususnya Sub Komite Kredensial, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan akan dilakukan secara berkala.

Semoga panduan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL.....i

PENGESAHANii

TIM PENYUSUNiii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

PERATURAN DIREKTURvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Maksud dan Tujuan1

1.3 Pengertian2

BAB II RUANG LINGKUP3

2.1 Staf Medis yang di Kredensial.....3

2.2 Proses Kredensial.....3

2.3 Proses Rekredensial.....3

2.4 Penetapan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilage*).....4

2.5 Peran dan Tanggung Jawab4

2.6 Dokumen Kredensial dan Rekredensial4

2.7 Monitoring dan Evaluasi.....4

BAB III TATA LAKSANA5

3.1 Pelaksana Kredensial dan Rekredensial.....5

3.2 Langkah Persiapan Pelaksanaan Kredensial.....6

3.3 Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).....8

3.4 Penugasan Klinis10

3.5 Rekredensial12

3.6 Proses Rekredensial.....12

BAB IV DOKUMENTASI14

4.1 Tujuan Dokumentasi14

4.2 Jenis Dokumen Kredensial14

4.3 Jenis Dokumen Rekredensial14

4.4 Pengelolaan Dokumen.....15

4.5 Kerahasiaan.....15

4.6 Penyimpanan15

4.7 Pemusnahan.....15

4.8 Monitoring dan Evaluasi.....15

BAB V PENUTUP16



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 946.2/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL STAF MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, maka rumah sakit wajib memastikan kompetensi staf medis yang akan memberikan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. bahwa agar pelaksanaan kredensial, rekredensial serta pemberian kewenangan klinis staf medis dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Panduan Kredensial dan re Kredensial Staf Medis
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL STAF MEDIS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Panduan Kredensial dan Re Kredensial ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
- (2) Rekredensial adalah proses evaluasi ulang secara berkala terhadap tenaga medis yang telah memiliki kewenangan klinis.



- (3) Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus yang diberikan kepada staf medis untuk melakukan tindakan medis tertentu di rumah sakit.
- (4) Komite Medik adalah perangkat rumah sakit yang bertanggung jawab menjaga profesionalisme staf medis.
- (5) Subkomite Kredensial adalah bagian dari Komite Medik yang melaksanakan proses kredensial dan rekredensial.

BAB II TATA LAKSANA

Pasal 2 Proses Kredensial

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga dokter meliputi :
 - a. Sesuai peraturan dan perundang – undangan;
 - b. Melakukan kredensial terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman, informasi yang ada pada setiap dokter;
 - c. Memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber utama;
- (2) Proses kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kompetensi, kewenangan klinis, dan profesionalisme dokter sesuai standar profesi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit;
- (3) Proses kredensial dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi
- (4) Kredensial tenaga medis dilaksanakan oleh Komite Medik melalui Sub Komite Kredensial;
- (5) Direktur Rumah Sakit menetapkan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
- (6) Waktu pelaksanaan setiap 3 tahun sebelum masa berlaku kewenangan klinis berakhir dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan

Pasal 3 Dokumen Kredensial

- (1) Rumah sakit menyediakan dan memelihara dokumen kredensial yang lengkap, sah, dan terbaru untuk setiap tenaga medis;
- (2) Tersedia bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman yang terbaru di file tenaga medis;
- (3) Dokumen kredensial tenaga medis sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Surat permohonan kewenangan klinis
 - b. Ijazah pendidikan profesi dan spesialis
 - c. STR yang masih berlaku
 - d. SIP yang masih berlaku
 - e. Sertifikat kompetensi
 - f. Curriculum Vitae
 - g. Sertifikat pelatihan yang relevan
 - h. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan rumah sakit



Pasal 4
Verifikasi Dokumen

- (1) Terdapat pelaksanaan verifikasi ke sumber Badan/ Lembaga/ Institusi penyelenggara pendidikan/ pelatihan yang seragam;
- (2) Rumah sakit menerapkan proses untuk memastikan bahwa kredensial dokter kontrak lengkap sebelum penugasan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR
TENTANG PANDUAN KREDENSIAL
DAN RE KREDENSIAL STAF MEDIS

PANDUAN KREDENSIAL DAN SUBKREDENSIAL STAF MEDIS

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasien adalah dengan menjaga profesional profesi dan kompetensi para staf medis yang melakukan tindakan medis terhadap pasien di rumah sakit. Dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat dan banyaknya faktor yang mempengaruhi kompetensi dokter / dokter gigi dalam melakukan tindakan medis sesuai keahliannya, yang telah mendapatkan pengakuan dari kolegium, rumah sakit wajib melakukan evaluasi dan verifikasi kompetensi dokter / dokter gigi tersebut, untuk menentukan apakah dokter / dokter gigi yang bersangkutan layak diberi kewenangan klinis (*clinical previledges*).

Kredensial merupakan proses evaluasi terhadap kompetensi, kewenangan klinis, perilaku profesional, dan kesehatan fisik maupun mental staf medis untuk menentukan kelayakan dalam memberikan pelayanan medis di rumah sakit. Proses ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan hukum bagi rumah sakit maupun staf medis.

Rekredensial merupakan proses evaluasi ulang secara berkala terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis guna memastikan kompetensi dan kinerja profesional tetap memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Panduan Kredensial dan Re Kredensial disusun sebagai acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan proses kredensial dan rekredensial staf medis secara terstruktur, objektif, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap staf medis yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi, kewenangan klinis, dan profesionalisme yang sesuai sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien dapat terjamin.

2. Tujuan Umum

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kredensial dan rekredensial staf medis guna memastikan bahwa setiap staf medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit memiliki kompetensi, kewenangan klinis, dan perilaku profesional yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien dapat terjamin.

3. Tujuan Khusus

- a. Menilai kompetensi staf medis sebelum diberikan kewenangan klinis.
- b. Menetapkan kewenangan klinis sesuai kemampuan dan kompetensi.
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja staf medis.
- d. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- e. Menjadi dasar pemberian, perubahan, atau pencabutan kewenangan klinis.

4. Pengertian

- a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- b. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis Rumah Sakit terjaga profesionalisme melalui kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Komite medic merupakan organisasi nonstruktural yang dibentuk di rumah sakit oleh kepala/ direktur dan bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
- c. Tenaga medis adalah tenaga profesional di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, memiliki kompetensi, registrasi, dan kewenangan untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerimaan Tenaga Medis adalah proses rekrutmen, seleksi, verifikasi, dan penetapan tenaga medis oleh rumah sakit untuk memperoleh tenaga medis yang kompeten, memiliki legalitas praktik, serta memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga medis atau staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis berdasarkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, perilaku profesional, serta kelengkapan legalitas yang dimiliki.
- f. Rekredensial adalah proses evaluasi ulang secara berkala terhadap tenaga medis atau staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk memastikan bahwa kompetensi, kinerja profesional, perilaku, dan kualitas pelayanan yang diberikan masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh rumah sakit dan profesi.
- g. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*)
- h. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan kepala/ direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
- i. Mitra bestari/ peer group adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait profesi medis

BAB II

RUANG LINGKUP

Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit Prima Husada dan semakin meningkatnya tuntutan Masyarakat akan pelayanan yang lebih bermutu, maka perlu diselenggarakan kendali mutu melalui sub komite kredensial. Setiap rumah sakit harus melaksanakan tata kelola klinis yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan medis, menjamin dan melindungi keselamatan pasien dan mengatur penyelenggaraan Komite Medis di setiap rumah sakit dalam rangka meningkatkan profesionalisme staf medis.

Komite medik memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit. Peran tersebut meliputi rekomendasi pemberian izin melakukan pelayanan medis di rumah sakit (clinical appointment) termasuk rinciannya (delineation of clinical privilege), memelihara kompetensi dan etika profesi, serta menegakkan disiplin profesi. Untuk itu kepala/direktur rumah sakit berkewajiban agar komite medis senantiasa memiliki akses informasi terinci tentang masalah keprofesian setiap staf medis di rumah sakit.

Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis ini berlaku bagi seluruh staf medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit, meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, serta tenaga medis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan rumah sakit.

Ruang lingkup panduan ini mencakup pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan kredensial, verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, pemberian kewenangan klinis (clinical privilege), penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK), pelaksanaan rekredensial secara berkala, evaluasi kinerja profesional, perubahan atau penyesuaian kewenangan klinis, pembatasan, penangguhan, maupun pencabutan kewenangan klinis. Ruang lingkup panduan meliputi:

2.1 Staf Medis yang di Kredensial

1. Dokter Umum.
2. Dokter Gigi.
3. Dokter Spesialis.
4. Dokter Gigi Spesialis.
5. Dokter Subspesialis.
6. Dokter tamu atau dokter konsultan sesuai kebijakan rumah sakit.

2.2 Proses Kredensial

1. Pengajuan permohonan kewenangan klinis.
2. Verifikasi dokumen administratif dan legalitas praktik.
3. Penilaian kompetensi dan profesionalisme.
4. Penilaian kesehatan fisik dan mental apabila diperlukan.
5. Penilaian kewenangan klinis yang diajukan.
6. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis oleh Komite Medik.
7. Penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK) oleh Direktur Rumah Sakit.

2.3 Proses Rekredensial

1. Evaluasi ulang kompetensi staf medis secara berkala.
2. Penilaian kinerja profesional.
3. Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan medis.

-
4. Penilaian hasil audit medis dan indikator mutu.
 5. Penilaian kepatuhan terhadap program keselamatan pasien.
 6. Peninjauan kembali kewenangan klinis yang dimiliki.

2.4 Penetapan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilage*)

1. Pemberian kewenangan klinis sesuai kompetensi.
2. Perubahan atau penambahan kewenangan klinis.
3. Pembatasan kewenangan klinis.
4. Penangguhan kewenangan klinis.
5. Pencabutan kewenangan klinis.

2.5 Peran dan Tanggung Jawab

1. Direktur Rumah Sakit.
2. Komite Medik.
3. Subkomite Kredensial.
4. Ketua Staf Medis Fungsional (SMF).
5. Mitra Bestari (peer reviewer).
6. Staf Medis yang bersangkutan.

2.6 Dokumen Kredensial dan Rekredensial

1. Formulir permohonan kredensial.
2. Daftar rincian kewenangan klinis.
3. Berita acara kredensial dan rekredensial.
4. Surat rekomendasi Komite Medik.
5. Surat Penugasan Klinis (SPK).
6. Dokumen evaluasi kinerja profesional.

2.7 Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan kewenangan klinis.
2. Evaluasi berkala terhadap kinerja staf medis.
3. Tindak lanjut hasil audit medis, insiden keselamatan pasien, dan keluhan pasien yang berkaitan dengan kompetensi staf medis.

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Pelaksana Kredensial dan Rekredensial

Kredensial dilakukan terhadap seluruh staf medis yang akan memberikan pelayanan medis di rumah sakit untuk memperoleh kewenangan klinis sesuai kompetensinya.

Pelaksana proses kredensial dan rekredensial di rumah sakit adalah sub komite kredensial yang anggotanya telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite Medik berikut tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaannya Komite Medik dan Sub Komite Kredensial berhak meminta bantuan kepada mitra bestari yang telah ditetapkan untuk menilai masing-masing bidang kompetensi. Peserta kredensial adalah dokter umum / dokter gigi / dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter sub spesialis yang mengajukan permohonan untuk bekerja di rumah sakit baik purna waktu maupun paruh waktu. Selain itu bagi dokter yang hanya menggantikan sementara maupun konsultan suatu bagian yang tidak memiliki surat izin praktek (SIP) di Rumah Sakit Prima Husada wajib dilakukan kredensial dengan mengumpulkan syarat yang telah ditetapkan. Peserta rekredensial adalah dokter umum / dokter gigi / dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter sub spesialis yang telah bekerja di rumah sakit baik purna waktu maupun paruh waktu pada akhir masa berlaku penugasan kliniknya.

1. Kredensial

Proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).

a. Tugas subkomite kredensial adalah :

- 1) Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari Staf Medis Fungsional (SMF) berdasarkan norma keprofesian yang berlaku
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku serta etika profesi
- 3) Mengevaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan
- 4) Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis
- 5) Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat
- 6) Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik
- 7) Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinik dan adanya permintaan dari Komite Medik
- 8) Rekomendasi kewenangan klinik dan penerbitan Surat Penugasan Klinik

b. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi Kewenangan Klinik :

- 1) Pendidikan
 - a) Lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi atau dari sekolah kedokteran luar negeri dan sudah diregistrasi
 - b) Menyelesaikan prodi konsultan
- 2) Perizinan (lisensi)
 - a) Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi
 - b) Memiliki izin praktik dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku
- 3) Kegiatan penjaminan mutu profesi
 - a) Menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya
 - b) Berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis

- 4) Kualifikasi personal
 - a) Riwayat disiplin dan etik profesi
 - b) Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui
 - c) Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien
 - d) Riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan
 - e) Memiliki asuransi proteksi profesi (*Professional Indemnity Insurance*)
- 5) Pengalaman di bidang keprofesian
 - a) Riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi
 - b) Riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi
- c. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen :
 - 1) Kompetensi
 - a) Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu
 - b) Kognitif
 - c) Afektif
 - d) Psikomotor
 - 2) Kompetensi fisik
 - 3) Kompetensi mental/ perilaku
 - 4) Perilaku etis (ethical standing)

3.2 Langkah Persiapan Pelaksanaan Kredensial

1. Identifikasi Kebutuhan Staf Medis
 - a. Rumah sakit melakukan analisis kebutuhan tenaga medis berdasarkan :
 - 1) Jenis pelayanan yang tersedia
 - 2) Beban kerja pelayanan
 - 3) Pengembangan layanan baru
 - 4) Ketersediaan staf medis yang ada
 - b. Direktur atau bagian SDM menyampaikan kebutuhan tenaga medis kepada Komite Medik.
2. Pengajuan Permohonan kredensial

Calon staf medis mengajukan permohonan kredensial kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Medik dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Calon staf medis menyerahkan dokumen sebagai berikut :

 - a. Surat permohonan menjadi staf medis.
 - b. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
 - c. Fotokopi KTP.
 - d. Pas foto terbaru.
 - e. Ijazah pendidikan profesi dan spesialis (bila ada).
 - f. STR yang masih berlaku.
 - g. SIP yang masih berlaku (jika telah memiliki).
 - h. Sertifikat kompetensi.
 - i. Sertifikat pelatihan yang relevan.
 - j. Surat rekomendasi organisasi profesi (bila diperlukan).
 - k. Surat pengalaman kerja.
 - l. Surat keterangan sehat fisik dan mental.
 - m. Surat pernyataan mematuhi peraturan rumah sakit.
4. Pembentukan Tim Kredensial

Ketua Komite Medik menugaskan Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Tim dapat terdiri dari :

-
- a. Ketua Subkomite Kredensial.
 - b. Anggota Subkomite Kredensial.
 - c. Mitra Bestari (peer reviewer) sesuai bidang keahlian.
5. Verifikasi Administratif
- Subkomite Kredensial melakukan pemeriksaan terhadap :
- a. Keabsahan ijazah.
 - b. Keabsahan STR.
 - c. Keabsahan SIP.
 - d. Sertifikat kompetensi.
 - e. Kelengkapan dokumen lainnya.
- Hasil verifikasi dicatat dalam formulir verifikasi kredensial.
6. Penyusunan Daftar Kewenangan Klinis
- Calon staf medis mengisi :
- a. Daftar rincian kewenangan klinis (RKK).
 - b. Daftar tindakan yang dimohonkan sesuai kompetensi.
- Dokumen ini menjadi dasar penilaian kompetensi.
7. Penunjukan Mitra Bestari
- Apabila diperlukan, Komite Medik menunjuk Mitra Bestari yang memiliki kompetensi sesuai bidang calon staf medis untuk melakukan penilaian sejawat.
8. Pengumpulan Data Pendukung
- Subkomite Kredensial mengumpulkan informasi terkait :
- a. Pengalaman praktik klinis.
 - b. Riwayat pekerjaan.
 - c. Riwayat pendidikan berkelanjutan.
 - d. Riwayat disiplin profesi (jika ada).
 - e. Hasil evaluasi dari tempat kerja sebelumnya (bila diperlukan).
9. Penjadwalan Proses Kredensial
- Subkomite Kredensial menetapkan :
- a. Jadwal wawancara.
 - b. Jadwal penilaian kompetensi.
 - c. Jadwal rapat kredensial.
 - d. Jadwal pembahasan hasil kredensial.
10. Pelaksanaan Wawancara Awal
- Wawancara dilakukan untuk menilai :
- a. Pemahaman terhadap etika profesi.
 - b. Komitmen terhadap mutu dan keselamatan pasien.
 - c. Kemampuan komunikasi.
 - d. Kesesuaian kompetensi dengan layanan rumah sakit.
11. Persiapan Rapat Kredensial
- Sebelum rapat, Subkomite Kredensial menyiapkan :
- a. Berkas calon staf medis.
 - b. Hasil verifikasi dokumen.
 - c. Hasil wawancara.
 - d. Hasil penilaian Mitra Bestari.
 - e. Draft rekomendasi kewenangan klinis.
12. Penyusunan Berita Acara dan Formulir Penilaian
- Dokumen yang harus disiapkan :
- a. Formulir kredensial.
 - b. Checklist verifikasi dokumen.
 - c. Formulir penilaian kompetensi.
 - d. Formulir rekomendasi kewenangan klinis.
 - e. Berita acara rapat kredensial.

3.3 Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

1. Pengertian Kewenangan Klinis

Kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan pelayanan medis dan tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit berdasarkan kompetensi, pendidikan, pelatihan, pengalaman, kondisi kesehatan, perilaku profesional, serta hasil proses kredensial yang telah dilakukan oleh Komite Medik.

Kewenangan klinis diberikan secara individual kepada setiap staf medis dan dapat berbeda antara satu staf medis dengan staf medis lainnya sesuai hasil penilaian kompetensi yang dilakukan dalam proses kredensial maupun rekredensial.

2. Tujuan Pemberian Kewenangan Klinis

- Menjamin bahwa pelayanan medis diberikan oleh staf medis yang kompeten sesuai bidang keahliannya.
- Menjamin keselamatan pasien melalui pelayanan medis yang profesional dan bermutu.
- Menjadi dasar hukum bagi staf medis dalam melaksanakan praktik klinis di rumah sakit.
- Menyesuaikan jenis pelayanan dan tindakan medis dengan kemampuan serta kompetensi staf medis.
- Melindungi pasien, staf medis, dan rumah sakit dari risiko pelayanan yang tidak sesuai kompetensi.
- Meningkatkan mutu pelayanan medis secara berkesinambungan.
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi rumah sakit.

3. Prinsip Pemberian Kewenangan Klinis

- Kompetensi
- Keselamatan pasien
- Objektifitas
- Akuntabilitas
- Transparansi
- Keadilan

4. Dasar Penetapan Kewenangan Klinis

- Ijazah pendidikan profesi dan spesialis.
- Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan.
- Sertifikat kompetensi.
- Sertifikat pelatihan yang relevan.
- Pengalaman kerja dan pengalaman klinis.
- Logbook tindakan medis (apabila diperlukan).
- Hasil penilaian kredensial.
- Hasil penilaian Mitra Bestari (peer review).
- Kebutuhan pelayanan rumah sakit.
- Ketersediaan sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya pendukung.
- Hasil evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

5. Ruang lingkup Kewenangan Klinis

- Kewenangan klinis diagnostik
- Kewenangan klinis terapeutik
- Kewenangan klinis konsultatif
- Kewenangan klinis rehabilitatif

6. Jenis Kewenangan Klinis

- Kewenangan klinis penuh

-
- Diberikan kepada staf medis yang memenuhi seluruh persyaratan kompetensi untuk melaksanakan seluruh tindakan medis sesuai bidang keahliannya.
- b. Kewenangan klinis terbatas
Diberikan kepada staf medis yang hanya diperbolehkan melakukan tindakan tertentu dengan batasan yang telah ditetapkan.
 - c. Kewenangan klinis bersyarat
Diberikan dengan persyaratan tertentu seperti pendampingan, supervisi, atau pelatihan tambahan.
 - d. Kewenangan klinis sementara
Diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
7. Proses Pemberian Kewenangan Klinis
- a. Tahap 1 : Pengajuan Permohonan
Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite Medik dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. Tahap 2 : Verifikasi Dokumen
Sub komite kredensial melakukan verifikasi terhadap :
 - 1) Legalitas praktik
 - 2) Pendidikan
 - 3) Sertifikasi
 - 4) Pengalaman klinis
 - 5) Kelengkapan administrasi
 - c. Tahap 3 : Penilaian Kompetensi
Penilaian dilakukan melalui :
 - 1) Telaah dokumen
 - 2) Wawancara
 - 3) Penilaian mitra bestari
 - 4) Evaluasi pengalaman klinis
 - 5) Evaluasi logbook tindakan
 - d. Tahap 4 : Penyusunan Rekomendasi
Subkomite Kredensial menyusun rekomendasi mengenai :
 - 1) Jenis kewenangan klinis
 - 2) Ruang lingkup tindakan yang diperbolehkan
 - 3) Batasan kewenangan apabila diperlukan
 - e. Tahap 5 : Penetapan
Direktur Rumah Sakit menetapkan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
 - f. Tahap 6 : Penerbitan Surat Penugasan Klinik (SPK)
SPK diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan praktik klinis di rumah sakit.
8. Masa Berlaku Kewenangan Klinis
- a. Kewenangan klinis berlaku sesuai masa berlaku SPK.
 - b. Masa berlaku umumnya 3 (tiga) tahun atau sesuai kebijakan rumah sakit.
 - c. Sebelum masa berlaku berakhir dilakukan rekredensial.
 - d. Evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. Perubahan Kewenangan Klinis
- Perubahan kewenangan klinis dapat dilakukan apabila :
- a. Terdapat peningkatan kompetensi.
 - b. Terdapat sertifikasi baru.
 - c. Perubahan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
 - d. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan perlunya perubahan kewenangan.
 - e. Adanya teknologi atau metode pelayanan baru.
10. Pembatasan Kewenangan Klinis

Pembatasan kewenangan klinis dapat dilakukan apabila :

- a. Kompetensi belum memenuhi persyaratan tertentu.
- b. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya pembinaan.
- c. Ditemukan ketidaksesuaian praktik profesional.
- d. Adanya masalah keselamatan pasien.
- e. Sarana dan prasarana belum mendukung pelaksanaan tindakan tertentu.

11. Penangguhan Kewenangan Klinis

Kewenangan klinis dapat ditangguhkan apabila :

- a. Sedang menjalani proses investigasi etik atau disiplin.
- b. STR atau SIP tidak berlaku.
- c. Tidak memenuhi persyaratan administratif.
- d. Tidak mengikuti ketentuan rumah sakit yang berkaitan dengan mutu dan keselamatan pasien.

12. Pencabutan Kewenangan Klinis

Kewenangan klinis dapat dicabut apabila :

- a. Mengundurkan diri dari rumah sakit.
- b. STR dicabut oleh instansi berwenang.
- c. Terbukti melakukan pelanggaran etik atau disiplin berat.
- d. Terbukti melakukan tindakan yang membahayakan pasien.
- e. Tidak memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan hasil rekredensial.

13. Dokumentasi Kewenangan Klinis

Dokumen yang harus dipelihara meliputi :

- a. Formulir permohonan kewenangan klinis.
- b. Rincian Kewenangan Klinis (RKK).
- c. Hasil kredensial dan rekredensial.
- d. Hasil penilaian Mitra Bestari.
- e. Berita acara rapat Komite Medik.
- f. Surat rekomendasi Komite Medik.
- g. Surat Penugasan Klinis.
- h. Dokumen perubahan, pembatasan, penangguhan, atau pencabutan kewenangan klinis.

14. Monitoring dan Evaluasi Kewenangan Klinis

Komite Medik melakukan monitoring dan evaluasi melalui :

- a. Audit medis.
- b. Peer review.
- c. Evaluasi indikator mutu.
- d. Evaluasi insiden keselamatan pasien.
- e. Evaluasi kepatuhan terhadap SPO.
- f. Evaluasi komplain pasien terkait pelayanan medis.
- g. Rekredensial secara berkala.

3.4 Penugasan Klinis

1. Pengertian

Penugasan Klinis adalah penugasan yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada staf medis untuk melaksanakan pelayanan medis dan tindakan klinis tertentu sesuai dengan kewenangan klinis yang telah ditetapkan melalui proses kredensial atau rekredensial.

Penugasan klinis diberikan dalam bentuk Surat Penugasan Klinis (SPK) yang menjadi dasar bagi staf medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien di lingkungan rumah sakit.

2. Tujuan

- a. Memberikan kewenangan resmi kepada staf medis dalam melaksanakan praktik profesional di rumah sakit.

-
- b. Menjamin bahwa pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang kompeten dan telah melalui proses kredensial.
 - c. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
 - d. Memberikan kepastian hukum bagi staf medis dan rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan medis.
 - e. Menyesuaikan penugasan pelayanan dengan kompetensi yang dimiliki staf medis.
3. Proses
- a. Pengajuan permohonan
Staf medis mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis melalui mekanisme yang ditetapkan rumah sakit.
 - b. Pelaksanaan kredensial
Subkomite Kredensial melakukan penilaian terhadap kompetensi dan kelayakan staf medis.
 - c. Rekomendasi Komite Medik
Hasil kredensial dibahas dalam rapat Komite Medik dan ditetapkan rekomendasi kewenangan klinis.
 - d. Penetapan oleh Direktur
Direktur Rumah Sakit menetapkan penugasan klinis berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
 - e. Penerbitan Surat Penugasan Klinis
Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) yang memuat rincian kewenangan klinis yang dapat dilakukan oleh staf medis.
4. Isi Surat Penugasan Klinis
- Surat Penugasan Klinis sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama staf medis.
 - b. Nomor STR.
 - c. Nomor SIP.
 - d. Bidang profesi atau spesialisasi.
 - e. Rincian kewenangan klinis yang diberikan.
 - f. Unit pelayanan tempat bertugas.
 - g. Masa berlaku penugasan klinis.
 - h. Ketentuan dan batasan pelaksanaan kewenangan klinis.
 - i. Tanda tangan Direktur Rumah Sakit.
5. Masa Berlaku Penugasan Klinis
- a. Penugasan klinis berlaku sesuai masa berlaku yang ditetapkan rumah sakit.
 - b. Umumnya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses rekredensial.
 - c. Penugasan klinis berakhir apabila :
 - 1) Masa berlaku telah habis.
 - 2) Staf medis mengundurkan diri.
 - 3) Hubungan kerja berakhir.
 - 4) STR atau SIP tidak berlaku.
 - 5) Kewenangan klinis dicabut.
6. Perubahan Penugasan Klinis
- a. Terdapat penambahan kompetensi baru.
 - b. Terdapat perubahan kewenangan klinis.
 - c. Adanya pengembangan layanan rumah sakit.
 - d. Hasil rekredensial merekomendasikan perubahan kewenangan.
 - e. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
7. Pembekuan atau Penangguhan Penugasan Klinis
- a. STR atau SIP tidak berlaku.
 - b. Sedang menjalani proses pemeriksaan etik atau disiplin profesi.
 - c. Ditemukan pelanggaran terhadap standar pelayanan medis.

- d. Terdapat risiko terhadap keselamatan pasien.
 - e. Berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
8. Pencabutan Penugasan Klinis
- a. Staf medis terbukti melakukan pelanggaran etik atau disiplin berat.
 - b. Kompetensi tidak lagi memenuhi persyaratan.
 - c. Terjadi pelanggaran yang membahayakan keselamatan pasien.
 - d. STR dicabut oleh instansi yang berwenang.
 - e. Staf medis tidak lagi bekerja di rumah sakit.

3.5 Rekredensial

1. Pengertian

Rekredensial adalah proses evaluasi ulang terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis dan Surat Penugasan Klinis (SPK) untuk menilai kelayakan perpanjangan, perubahan, pembatasan, penangguhan, atau pencabutan kewenangan klinis berdasarkan kompetensi, kinerja profesional, perilaku profesional, serta hasil pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Rekredensial dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa staf medis tetap kompeten dan mampu memberikan pelayanan medis yang aman, efektif, bermutu, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

2. Tujuan

- a. Menilai kembali kompetensi staf medis yang telah memperoleh kewenangan klinis.
- b. Memastikan staf medis tetap memenuhi standar profesi dan standar pelayanan medis.
- c. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- d. Menjadi dasar pemberian kembali Surat Penugasan Klinis (SPK).
- e. Menentukan perpanjangan, perubahan, pembatasan, penangguhan, atau pencabutan kewenangan klinis.
- f. Mendorong peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

3. Waktu Pelaksanaan Rekredensial

- a. Rekredensial dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai kebijakan rumah sakit.
- b. Rekredensial dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila :
 - 1) Masa berlaku Surat Penugasan Klinis akan berakhir.
 - 2) Terjadi perubahan kompetensi staf medis.
 - 3) Terjadi insiden keselamatan pasien yang memerlukan evaluasi kompetensi.
 - 4) Terdapat laporan pelanggaran etik atau disiplin profesi.
 - 5) Atas permintaan Direktur atau Komite Medik.

3.6 Prosedur Rekredensial

1. Persiapan Rekredensial

- a. Komite Medik membuat daftar staf medis yang akan habis masa berlaku kewenangan klinisnya.
- b. Pemberitahuan rekredensial disampaikan kepada staf medis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPK berakhir.
- c. Subkomite Kredensial menyiapkan formulir dan dokumen kredensial

2. Pengajuan Permohonan Rekredensial

- a. Formulir permohonan rekredensial.
- b. STR yang masih berlaku.

-
- c. SIP yang masih berlaku.
 - d. Daftar rincian kewenangan klinis yang dimohonkan.
 - e. Logbook tindakan medis.
 - f. Sertifikat pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
 - g. Data pendukung lainnya sesuai ketentuan rumah sakit.
3. Verifikasi Dokumen
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen.
 - b. Verifikasi keabsahan STR dan SIP.
 - c. Verifikasi sertifikat kompetensi.
 - d. Verifikasi dokumen pendukung lainnya.
 4. Pengumpulan Data Kinerja Profesional
 - a. Hasil audit medis.
 - b. Hasil peer review.
 - c. Data indikator mutu pelayanan.
 - d. Data insiden keselamatan pasien.
 - e. Data keluhan pasien terkait pelayanan medis.
 - f. Kepatuhan pengisian rekam medis.
 - g. Kehadiran dalam kegiatan Komite Medik dan staf medis.
 5. Penilaian Rekredensial
 - a. Telaah dokumen
 - b. Evaluasi kinerja profesional
 - c. Peer review atau Mitra Bestari
 - d. Wawancara
 6. Penyusunan Rekomendasi
 - a. Perpanjangan kewenangan klinis.
 - b. Penambahan kewenangan klinis.
 - c. Pembatasan kewenangan klinis.
 - d. Penangguhan kewenangan klinis.
 - e. Pencabutan kewenangan klinis.
 7. Pembahasan dalam Rapat Komite Medik

Hasil penilaian dan rekomendasi Subkomite Kredensial dibahas dalam rapat Komite Medik untuk memperoleh keputusan dan rekomendasi resmi.
 8. Penetapan oleh Direktur Rumah Sakit

Direktur Rumah Sakit menetapkan hasil rekredensial berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
 9. Penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK)

Apabila staf medis dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis yang baru sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan.

BAB IV

DOKUMENTASI

4.1 Tujuan Dokumentasi

1. Menjamin tersedianya bukti pelaksanaan proses kredensial dan rekredensial yang lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri.
2. Mendukung pengambilan keputusan dalam pemberian kewenangan klinis dan penugasan klinis.
3. Menjadi sumber informasi dalam proses monitoring, evaluasi, audit, dan akreditasi rumah sakit.
4. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data staf medis.
5. Menyediakan data yang diperlukan untuk proses rekredensial dan pengembangan profesional staf medis.

4.2 Jenis Dokumen Kredensial

1. Dokumen Administratif
 - a. Surat permohonan menjadi staf medis.
 - b. Curriculum Vitae (CV).
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - d. Pas foto terbaru.
 - e. Surat keterangan sehat.
 - f. Surat rekomendasi organisasi profesi apabila diperlukan.
2. Dokumen Legalitas
 - a. Ijazah pendidikan profesi.
 - b. Ijazah spesialis atau subspesialis (bila ada).
 - c. Surat Tanda Registrasi (STR).
 - d. Surat Izin Praktik (SIP).
 - e. Sertifikat kompetensi.
3. Dokumen Kredensial
 - a. Formulir kredensial.
 - b. Checklist verifikasi dokumen.
 - c. Daftar Rincian Kewenangan Klinis (RKK).
 - d. Hasil penilaian Subkomite Kredensial.
 - e. Hasil penilaian Mitra Bestari (peer review).
 - f. Berita acara rapat kredensial.
 - g. Rekomendasi Komite Medik.
 - h. Surat Penugasan Klinis (SPK).

4.3 Jenis Dokumen Rekredensial

1. Formulir permohonan rekredensial.
2. STR dan SIP yang masih berlaku.
3. Logbook tindakan medis.
4. Sertifikat pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
5. Data pemenuhan SKP.
6. Hasil audit medis.
7. Hasil peer review.
8. Data indikator mutu pelayanan.
9. Data insiden keselamatan pasien yang terkait.
10. Data komplain atau keluhan pasien yang telah diverifikasi.
11. Hasil evaluasi rekam medis.
12. Berita acara rapat rekredensial.

-
13. Rekomendasi Komite Medik.
 14. Surat Penugasan Klinis yang diperbarui.

4.4 Pengelolaan Dokumen

1. Seluruh dokumen kredensial dan rekredensial dikelola oleh Komite Medik melalui Subkomite Kredensial.
2. Dokumen disimpan dalam berkas kredensial masing-masing staf medis baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.
3. Setiap dokumen harus diberi identitas yang jelas dan mudah ditelusuri.
4. Dokumen harus tersusun secara sistematis dan diperbarui secara berkala.
5. Perubahan data staf medis wajib segera didokumentasikan dalam file kredensial.

4.5 Kerahasiaan Dokumen

1. Dokumen kredensial dan rekredensial bersifat rahasia.
2. Akses terhadap dokumen hanya diberikan kepada :
 - a. Direktur Rumah Sakit.
 - b. Komite Medik.
 - c. Subkomite Kredensial.
 - d. Tim survei atau auditor yang berwenang sesuai ketentuan.
3. Penggunaan dokumen di luar kepentingan kredensial dan rekredensial harus mendapat persetujuan Direktur Rumah Sakit.
4. Informasi yang terdapat dalam dokumen tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang.

4.6 Penyimpanan Dokumen

1. Dokumen disimpan di tempat yang aman dan terlindungi dari kerusakan, kehilangan, maupun akses yang tidak sah.
2. Dokumen elektronik harus memiliki sistem pengamanan dan cadangan data (backup).
3. Masa penyimpanan dokumen mengikuti ketentuan yang berlaku di rumah sakit dan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila staf medis berhenti bekerja, berkas kredensial tetap disimpan sesuai ketentuan retensi dokumen rumah sakit.

4.7 Pemusnahan Dokumen

1. Pemusnahan dokumen dilakukan setelah melewati masa retensi yang ditetapkan.
2. Pemusnahan harus dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi.
3. Pemusnahan dokumen harus dibuatkan berita acara dan mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

4.8 Monitoring dan Evaluasi Dokumentasi

1. Komite Medik melakukan evaluasi kelengkapan dokumen kredensial dan rekredensial secara berkala.
2. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sistem dokumentasi dan peningkatan mutu pengelolaan kredensial.
3. Ketidaklengkapan dokumen harus segera ditindaklanjuti dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis ini disusun sebagai acuan bagi Direktur Rumah Sakit, Komite Medik, Subkomite Kredensial, dan seluruh staf medis dalam melaksanakan proses kredensial dan rekredensial secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kredensial dan rekredensial merupakan salah satu upaya rumah sakit untuk memastikan bahwa setiap staf medis yang memberikan pelayanan kepada pasien memiliki kompetensi, kewenangan klinis, perilaku profesional, dan kemampuan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan kredensial dan rekredensial yang efektif, diharapkan mutu pelayanan medis, keselamatan pasien, dan profesionalisme staf medis dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rumah Sakit.

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses kredensial dan rekredensial wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam panduan ini. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, standar profesi, standar akreditasi rumah sakit, maupun kebijakan internal rumah sakit, maka panduan ini akan dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan.

Dengan ditetapkannya Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis ini, diharapkan pelaksanaan pemberian kewenangan klinis dan penugasan klinis dapat berjalan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep